

Identificación, recepción y comunicación con enfoque diferencial

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Garantizar que la atención y sus registros correspondan al paciente correcto y a su necesidad de comunicación.

2. Alcance y condiciones de uso

Cita, ingreso, valoración, intervención, egreso y comunicaciones. Incluye usuarios con discapacidad, menores, personas mayores y apoyos de comprensión.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Asignar cita con datos mínimos, contacto autorizado y modalidad

Asignar cita con datos mínimos, contacto autorizado y modalidad. Evitar diagnósticos en agendas compartidas y mensajes que expongan información reservada.

2. Al ingresar solicitar nombre completo y número de identificación, compararlos con agenda e

Al ingresar solicitar nombre completo y número de identificación, compararlos con agenda e historia y resolver discrepancias. No usar camilla, turno o reconocimiento visual como sustitutos de dos identificadores.

3. Confirmar ambos identificadores antes de intervención, entrega de documento y remisión

Confirmar ambos identificadores antes de intervención, entrega de documento y remisión. Si no hay documento disponible, aplicar proceso local de identificación temporal y conciliación, evitando duplicados.

4. Preguntar idioma, necesidad de apoyo, comunicación accesible y acompañante preferido

Preguntar idioma, necesidad de apoyo, comunicación accesible y acompañante preferido. No presumir incapacidad decisoria por diagnóstico, discapacidad o edad adulta avanzada.

5. Explicar actividad, contacto corporal y cuidados en lenguaje sencillo

Explicar actividad, contacto corporal y cuidados en lenguaje sencillo. Solicitar que la persona explique lo comprendido y resolver preguntas sin presionarla.

6. Registrar dificultades, apoyo utilizado y decisión

Registrar dificultades, apoyo utilizado y decisión. Ante barrera persistente o identidad no resuelta, posponer lo que no sea urgente y gestionar solución segura.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Dos identificadores por episodio.

Apoyos no sustituyen decisión del paciente capaz.

Contactos solo por canal autorizado.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Paciente e identificación	
Fecha hora y modalidad	
Contacto autorizado	
Discrepancia y resolución	
Apoyo de comunicación	
Acompañante elegido	
Información explicada	
Comprensión comprobada	
Decisión	
Autor y autenticación	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Prácticas seguras

Resolución 3100, 11.1.5: política, actividades, instancia proporcional, identificación, comunicación, infección, eventos y consentimiento, documentación y formación; aplicar los criterios pertinentes al servicio.

<https://www.minsalud.gov.co/salud/prestacion-servicios/Paginas/sistema-obligatorio-garantia-calidad.aspx>

Datos sensibles

Ley 1581 de 2012, artículos 4-6, 8-12 y 17-18; Decreto 1074 de 2015, reglas de tratamiento. Información de salud y finalidades opcionales requieren análisis de base jurídica, autorización cuando exigible y seguridad.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576